Checklist do centro hiperbárico

Normas do CFM para oxigenoterapia hiperbárica e para atendimento de intercorrências, e diretrizes de segurança da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH). Cada parte indica a fonte: o que é do CFM é exigência de fiscalização; o que é da SBMH é diretriz da especialidade.

Unidade / câmara _____ Data da conferência _____ Conferido por _____

1. Carrinho de emergência: medicamentos CFM, Grupo 3

	Item	Tem	Falta	Qtd.	Validade	Obs.
1	Adrenalina (epinefrina)	☐	☐			
2	Água destilada	☐	☐			
3	Dexametasona	☐	☐			
4	Diazepam	☐	☐			
5	Dipirona	☐	☐			
6	Glicose a 50%	☐	☐			
7	Hidrocortisona	☐	☐			
8	Prometazina	☐	☐			
9	Soro fisiológico a 0,9%	☐	☐			

Lista mínima do CFM para serviços com risco de anafilaxia e de intercorrência respiratória e cardiovascular. O roteiro de oxigenoterapia hiperbárica do CFM não traz lista própria; quantidades e itens a mais (por exemplo, para convulsão por toxicidade do oxigênio e hipoglicemia) ficam a cargo do responsável técnico.

2. Carrinho de emergência: equipamentos e materiais CFM, Grupo 3

	Item	Sim	Não	Obs.
1	Desfibrilador com monitor ou desfibrilador externo automático (DEA)	☐	☐	
2	Oxímetro de pulso	☐	☐	
3	Ambu (balão autoinflável) com reservatório e máscara	☐	☐	
4	Cânulas naso ou orofaríngeas (no mínimo, Guedel)	☐	☐	
5	Máscara laríngea	☐	☐	
6	Oxigênio medicinal: rede canalizada, ou cilindro fixo na parede ou em suporte próprio	☐	☐	
7	Máscara aplicadora e umidificador de oxigênio	☐	☐	
8	Seringas, agulhas e equipo para aplicação endovenosa	☐	☐	
9	Escalpe, butterfly e intracath (com o material para introdução)	☐	☐	
10	Caixa rígida coletora para perfurocortante	☐	☐	
11	EPI para intercorrências: luvas, máscaras e óculos	☐	☐	
12	Gaze	☐	☐	
13	Algodão	☐	☐	
14	Ataduras de crepe	☐	☐	
15	Luvas estéreis	☐	☐	

16	Tudo acessível em até quatro minutos	☐	☐	

3. Indicação e aplicação da oxigenoterapia hiperbárica

CFM, Res. 1.457/1995 e roteiro de vistoria

	Item	Sim	Não	Obs.
1	O serviço faz OHB de verdade: oxigênio puro em câmara pressurizada acima da pressão atmosférica (bolsa, tenda ou máscara em pressão ambiente não é OHB)	☐	☐	
2	Tipo de câmara identificado: multipaciente e/ou monopaciente	☐	☐	
3	Indicação feita por médico	☐	☐	
4	Indicação registrada em prontuário: data e hora da avaliação, diagnóstico ou indicação, número de sessões, duração e nível de pressão	☐	☐	
5	Aplicação feita por médico ou sob supervisão direta de médico	☐	☐	
6	Indicação dentro das aplicações reconhecidas pelo CFM (lista no item 4)	☐	☐	
7	Contraindicações absolutas respeitadas: uso de doxorrubicina, dissulfiram ou cisplatina; pneumotórax não tratado; gravidez	☐	☐	
8	Contraindicações relativas avaliadas antes do tratamento: infecção de vias aéreas superiores, DPOC com retenção de CO2, hipertermia, pneumotórax espontâneo prévio, cirurgia prévia de ouvido, esferocitose congênita, infecção viral aguda	☐	☐	
9	Encaminhamento do médico assistente e exame clínico antes do tratamento	☐	☐	
10	Tratamento em sessões, com registro de duração, nível de pressão, número total e intervalos	☐	☐	
11	Protocolos assistenciais escritos por indicação	☐	☐	

4. Indicações reconhecidas (conferir no prontuário)

CFM, Res. 1.457/1995

	Item	Sim	Não	Obs.
1	Embolias gasosas	☐	☐	
2	Doença descompressiva	☐	☐	
3	Embolias traumáticas pelo ar	☐	☐	
4	Intoxicação por monóxido de carbono ou inalação de fumaça	☐	☐	
5	Intoxicação por cianeto ou derivados	☐	☐	
6	Gangrena gasosa	☐	☐	
7	Síndrome de Fournier	☐	☐	
8	Outras infecções necrotizantes de partes moles: celulites, fasciites e miosites	☐	☐	
9	Isquemias agudas traumáticas: esmagamento, síndrome compartimental, reimplante de extremidades e outras	☐	☐	
10	Vasculites agudas alérgicas, medicamentosas ou por toxinas (aracnídeos, ofídios e insetos)	☐	☐	
11	Queimaduras térmicas e elétricas	☐	☐	
12	Lesões refratárias: úlceras de pele, pé diabético, escaras, úlcera por vasculite autoimune, deiscência de sutura	☐	☐	

13	Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosa	☐	☐	
14	Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco	☐	☐	
15	Osteomielites	☐	☐	
16	Anemia aguda quando não é possível transfundir	☐	☐	

5. Câmara multipaciente SBMH, Diretrizes de Segurança

	Item	Sim	Não	Obs.
1	Médico sempre presente no serviço durante a operação	☐	☐	
2	Operador externo e operador interno (médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem) em cada sessão	☐	☐	
3	Câmara com registro na Anvisa e certificado de projeto e fabricação (ABNT NBR 15.949 e 15.417; NR-15, anexo 6)	☐	☐	
4	Manômetro para cada ambiente da câmara, ligado direto, e manômetros de ar comprimido, oxigênio e sistema de incêndio	☐	☐	
5	Analisador contínuo de O2 do ambiente da câmara, com dois pontos de captação (alto e baixo)	☐	☐	
6	Termômetro e medidor de umidade	☐	☐	
7	Visão do interior (vigia, câmera e monitor)	☐	☐	
8	Fonia entre câmara, antecâmara e painel	☐	☐	
9	Cronômetros de compressão, descompressão, oxigênio e intervalos de ar	☐	☐	
10	Gerador de energia de emergência (obrigatório se trata doença descompressiva)	☐	☐	
11	Iluminação interna blindada, externa ou por fibra óptica	☐	☐	
12	Sistema de incêndio por aspersão (água pressurizada) com teste funcional a cada 6 meses	☐	☐	
13	Máscaras com válvula de demanda unidirecional e duplo selo facial	☐	☐	
14	Documentos: manuais de operação, instalação e manutenção; certificado das válvulas de segurança; certificados da câmara e das vigias; teste dos vasos (NR-13) a cada 5 anos; manual de procedimentos de emergência	☐	☐	
15	Casa de máquinas: vasos de pressão conforme NR-13; ar comprimido conforme NBR 12.188, com resfriamento e filtragem	☐	☐	
16	Oxigênio com suprimento primário e reserva	☐	☐	
17	Lista de verificação diária preenchida antes da primeira sessão (compressor, filtros, ar, oxigênio, painel, câmara, incêndio, paciente)	☐	☐	
18	Durante a sessão: O2 do ambiente monitorado o tempo todo; renovar o ar acima de 23% e interromper o oxigênio acima de 23,5%	☐	☐	
19	Atenção ao ar dos frascos de soro na descompressão (risco de acelerar a infusão)	☐	☐	
20	Limpeza diária com quaternário de amônio e terminal semanal; silenciadores inspecionados todo mês	☐	☐	
21	Testes periódicos: estanqueidade, casco, reservatórios, sistema anti-incêndio, manômetros e válvulas de segurança	☐	☐	

6. Câmara monopaciente

SBMH, Diretrizes de Segurança

	Item	Sim	Não	Obs.
1	Médico presente no serviço durante o tratamento	☐	☐	
2	Câmara com registro na Anvisa	☐	☐	
3	ART da instalação do sistema de gases	☐	☐	
4	Exaustão para fora do prédio, a 3 metros de qualquer fonte de calor ou faísca, com cotovelo para baixo e tela	☐	☐	
5	Placa "PERIGO DE INCÊNDIO" junto à exaustão	☐	☐	
6	Projeto físico conforme RDC Anvisa 50/2002 e vigilância sanitária local	☐	☐	
7	Instalação elétrica conforme NBR 13.534 e câmara aterrada	☐	☐	
8	Paciente aterrado com pulseira antiestática, conforme o fabricante	☐	☐	
9	Celular a mais de 2 metros da câmara em funcionamento	☐	☐	
10	Sem luz solar direta sobre a câmara	☐	☐	
11	Climatização entre 18 e 22 °C, umidade de 40 a 60%, filtro G3 no mínimo	☐	☐	
12	Plano de incêndio da brigada ou do Corpo de Bombeiros	☐	☐	
13	Extintores (água pressurizada para a câmara e CO2 para equipamentos elétricos) e alarme operacionais	☐	☐	
14	Sensor de fumaça na sala (recomendado)	☐	☐	
15	Placas de aviso de ambiente rico em oxigênio num raio de 10 metros	☐	☐	
16	Verificação diária assinada: vedação, porta e conexões, válvulas e tubulações, pressão da rede, fluxômetro, ruídos, parte elétrica e imobilidade da câmara	☐	☐	
17	Limpeza só com água ou com produto indicado pelo fabricante	☐	☐	

7. Segurança do paciente na sessão

SBMH, Diretrizes de Segurança

	Item	Sim	Não	Obs.
1	Roupa 100% algodão, sem bolsos, sem metal e sem velcro, inclusive a íntima; roupa de cama 100% algodão	☐	☐	
2	Vistoria da entrada de cada paciente por um funcionário	☐	☐	
3	Retirados: metais, óculos, lentes de contato, próteses externas e dentárias móveis, aparelhos auditivos, perucas, eletrônicos e qualquer coisa que faça faísca	☐	☐	
4	Sem cremes, pomadas, álcool, iodo, óleos, perfume, maquiagem, esmalte, gel ou fixador de cabelo	☐	☐	
5	Sem papel, brinquedo com metal, chiclete ou bala	☐	☐	
6	Drenos, sondas e cateteres abertos e ligados a frasco de PVC; balonetes cheios de água	☐	☐	
7	Órtese metálica coberta com algodão molhado; cabelos molhados	☐	☐	
8	Sinais vitais antes e depois da sessão	☐	☐	
9	Última refeição verificada; glicemia capilar antes e depois em diabéticos, em casos selecionados	☐	☐	

10	Marca-passo interno ajustado conforme o fabricante	☐	☐	

8. Equipe SBMH, Diretrizes de Segurança

	Item	Sim	Não	Obs.
1	Equipe treinada para as tarefas e para as emergências	☐	☐	
2	Lista de verificação do serviço cumprida e arquivada	☐	☐	
3	Familiares, quando permitidos pelo médico, orientados nas normas de segurança	☐	☐	
4	Cal sodada manuseada com EPI (óculos vedados, avental de manga longa, luvas e máscara PFF1)	☐	☐	

Responsável pela conferência

Responsável técnico (nome e CRM)

Fontes: Conselho Federal de Medicina, Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (anexo da Resolução CFM nº 2.153/2016, que atualiza a nº 2.056/2013; versão do site do CFM consultada em 20/10/2026): roteiro "Oxigenoterapia Hiperbárica" (páginas 949 a 952) e equipamentos e medicamentos mínimos do Grupo 3 (páginas 179 e 180). Resolução CFM nº 1.457/1995 (oxigenoterapia hiperbárica). Parecer CFM nº 08/2011 (contraindicações). Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, Diretrizes de Segurança, Qualidade e Ética, 6ª revisão (2016 a 2018), capítulos 2 e 3; conferir se há versão mais nova no site da SBMH. Instalações também seguem RDC Anvisa 50/2002, NR-13, NR-15 (anexo 6) e normas ABNT citadas.